

Anamnèse par système :

Général: pas d'EF ni de frisson, Fatigue, pas de notion de perte de poids, pas de sudation nocturne, appétit conservé

Neuro: pas de céphalée, pas de vertige, pas de perte d'équilibre, pas de parésie, ni de paresthésie, pas de diplopie, absence de trbl. de la déglutition/phonation, pas de dysarthrie. Pas de troubles vésico-sphinctériens ni d'anesthésie en selle.

CV: pas de dyspnée, pas de DRS, pas de palpitation, pas d'orthopnée, pas de DPN, pas de nycturie, pas d'OMI, aucune notion de syncope

Resp: pas de dyspnée, pas de dou. respiro-dépendante, pas de toux, pas d'expectoration (couleurs, quantité, fréquence), pas d'hémoptysie

Dige: pas de nausée/vomissement, pas de dyspepsie, transit sans particularité, pas de melena/hématochézie, pas de notion d'incontinence

GynUro: pas de perte vaginale, pas de dysurie, pas de dyspareunie, pas de pollakiurie, pas d'hématurie, puissance du jet sp, pas de notion d'incontinence

OA: pas de douleur articulaire, pas de rougeur ou tuméfaction, pas d'impotence fonctionnelle

ORL: pas de traumatisme crânien ou facial, pas de traumatisme acoustique, ne joue pas d'instrument de musique, pas de plongée récente (avec douleur uni/bilatérale) , pas de séjour en altitude récent (avec douleur uni/bilatérale), pas d'écoulement (séreux/sanguin)

Examen clinique :

Gén : pas de fièvre ni frisson, signes vitaux, pas de signe de déshydratation (test du pli cutané positif, langue rôtie), thymie conservée

Tég : pigmentation sp, pas de lésion focale, pas de plaie, pas de naevus suspect

Neuro : orienté dans les 3 modes, GCS 15/15. Pupilles isochores-isoréactives. Pas de signes méningés. NC II-XII dans la norme, pas de diplopie, pas de skew deviation.

Épreuves de stabilisation tenues aux membres supérieurs et inférieurs. Force tétra-appendiculaire M5 symétrique. Sensibilité grossière tétra-appendiculaire conservée. Lasèque nég.

Tonus normal sans clonus, absence de roue dentée. ROT symétriques et normovifs sans extension ni diffusion. RCP en flexion ddc, Hoffman nég. ddc. Pas de troubles de la motricité fine. Épreuves doigt-nez et talon-genou sp. aux 4 membres.

Romberg / Unterberger sp. Marche spontanée, sur la pointe, les talons et en funambule sp.

Cardio : B1B2 bf, régulier, pas de souffle perçu. Auscultation des carotides sp. Pouls carotidiens, radiaux et pédieux bien palpés. TRC < 3 secondes aux 4 membres. Pas de turgescence jugulaire ni reflux hépato-jugulaire. Mollets souples et indolores, Homans nég, pas d'OMI

Resp : acyanotique. Pas d'ADP palpé dans les régions cervicales et axillaires ddc. Pas de douleurs reproductibles à la palpation, pas d'emphysème sous-cutané. Murmure vésiculaire normaux et symétriques, sans bruits surajoutés

Abdo : BNFT, abdomen souple et indolore à la palpation, pas de défense ni détente, signes de Murphy nég., McBurney nég., test du psoas nég., Rosving nég. Pas d'hépatosplénomégalie, pas de masse palpable. Pas d'ADP des régions inguinales ddc. LRSI. Pas d'orifice herniaire palpés, pas de hernie palpée.

OA : pas de douleur à la palpation et la percussion du rachis et des sacro-iliaques, pas de tuméfaction articulaire, pas de limitation articulaires

ORL: pas d'ADP cervicale, CAE et tympan sans particularité. Bon état dentaire, muqueuse buccale sp, pas de signe de mycose. Fond de gorge calme, tonsilles grade 0

Examen clinique neurologique complet (canevas NLG-CHUV) :

Neurocomportement : Vigilance et attention normales, bonne collaboration, bonne orientation à la date et situation, nosognosique. Pas de comportement désinhibé ni réflexes archaïques, pas de signes affectifs. Discours cohérent sans dysarthrie, empan verbal ____ Langage fluent, informatif, sans paraphasie. Dénomination, répétition, lecture et écriture préservées. Pas de signes d'héminégligence visuelle/sensitive/auditive/comportementale. Mémoire épisodique: rappel immédiat libre ____/5, rappel immédiat indicé ____/5, rappel différé libre ____/5, rappel différé indicé ____/5 après 5 min. Imitation de gestes sans signification correcte.

Nerfs crâniens : Pas de méningisme. Pupilles isochores et isoréactives à la lumière, sans RAPD. Acuité visuelle corrigée: OD ..., OG Fond d'œil sp. Champs visuels sans amputation dans les 4 quadrants. Oculomotricité lisse, sans limitation sur le plan horizontal ni vertical. Absence de nystagmus spontané ou au regard excentré. Pas de correction saccadique/«skew deviation» au «alternate cover test». Sensibilité du visage normale au toucher et au piquer. Motricité du visage symétrique, sans parésie aux mouvements spontanés et volontaires. Head thrust horizontal (Halmagyi) physiologique. Manoeuvre de Barany-Hallpike ne déclenche pas de vertiges/nystagmus. Palais symétrique, voix normale. Force normale des trapèzes et sternocléidomastoïdiens. Trophicité et protrusion de la langue sp. Réflexe massétéрин non augmenté.

Voies longues : Epreuve de stabilisation tenue aux membres supérieurs et inférieurs. Motilité fine rapide et symétrique au pianotage. Tonus et trophisme musculaires normaux. Force segmentaire des 4 extrémités normale proximale et distale. ROT normovifs et symétriques au niveau bicipital, tricipital, stylo-radial, rotulien et achilléen. Réflexe de Hoffmann-Trömner normovif ddc. RCP en flexion ddc.

Pas de tremblement au repos, postural ni cinétique. Pas de rigidité axiale ni des extrémités, pas de mouvements anormaux.

Épreuves cérébelleuses eumétriques aux 4 extrémités, pas de dysdiadococinésie. Test du rebond négatif aux membres supérieurs.

Sensibilité tacto-algique, pallesthésie et sens postural symétriques et préservés.

Marche : Posture et station sp. Romberg négatif. Marche : spontanée normale, possible sur pointes, talons et en funambule. Saut unipodal possible ddc.

TIP :

Problème 1: diagnostic détaillé avec le degré de probabilité (probable, possible, ...), date
(Diagnostic différentiel ou contexte spécifique si pas dans suite du prbl)

CTX: contexte global de l'hospitalisation, avec les plaintes principales // mettre comme grande visite, connu pour+ttt

S: subjectif, report des plaintes du patient (anamnèse)

O: objectif, report de tout ce qui est observé durant l'EC

A: assessment, diagnostic différentiel

P: procédure, attitude générale de la PEC y.c. ce qui a déjà été fait aux urgences ou à l'admission

Notes urgences:

Patient de xx ans, connu pour, qui présente

Cliniquement le patient est :

A B C D

labo :

Imagerie :

Attitude :

NDS :

HD : stable

Neuro : douleur, confort, GCS /15, Orienté

CV : RSR

Resp : acyanotique, eupnéique

Dige : apports protéino-cal., sonde, transit ?

Uro : bilan, apports, sonde ?

Infectio : KT / VVP / VVC calmes, cutané, ATB

Hémato: thromboprophylaxie par

Hémato :

Erythro _T/L, Hb _g/L, MCV _fl, MCH _pg, MCHC _g/L, Ferritine _ug/L, Sat. transferrine _%

Inflammation :

Leuco _G/L, CRP _mg/L

Bilan rénal:

Créat _umol/L, Na _mmol/L, K _mmol/L, Urée _mmol/L

Bilan hépato / pancréas:

ASAT _U/L, ALAT _U/L, GGT _U/L, PhosAlc _U/L, Lipase _U/L, Bili totale _mmol/L, Bili directe _mmol/L, Albumine _g/L

Spécifiques :

DDim _ng/L, BNP _pg/L, Trop hX _ng/L, CK _U/L, CKMB _U/L, TSH _mU/L, LDH _U/L, bHCG _U/L, HCG total _U/L, AFP _ng/ml

Ions:

CaMesu _mmol/L, CaCorr _mmol/L, Phos _mmol/L, Mg _mmol/L,

Sédiment urinaire :

Leuco _ (_ - _ /champ), Nitrites _, Prot _, Glu _, Corps Céto _, Urobilinogène _, Bili urinaire _, Sang _, Erythro _, Flore bact _

Spot urinaire :

Créat urinaire _mmol/L, Prot urinaires _g/L, Prot/Créat _g/mmol

ECG :

FC _bpm. Rythme sinusal, régulier. Onde P <25mm, PR _ms. QRS fins, axe : _°, pas de trouble de conduction. Transition des QRS en V_, indice de Sokolow nég. ST isoélectrique. Onde T concordantes, positives dans les précordiales V2 à V6. QTc _ms.

SERVICE - HÔPITAL

Nom, Prénom, ddn

Echographie POCUS abdomino-pelvienne

Indication :

Technique : Ultrason abdominal, Machine, Sonde

Qualité d'examen :

Résultats :

Aorte abdominale : diamètre <2.5cm en supra-rénal, <2cm en infra-rénal

Foie : échogénicité et morphologie normales. Absence de lésion focale suspecte. Mesure ___cm sur la ligne médio-claviculaire. Absence de liquide libre péri-hépatique.

Système porte perméable avec flux hépatopète.

Veines hépatiques perméables avec flux hépatofuge.

Vascularisation artérielle hépatique perméable.

Vésicule biliaire : paroi exempte d'anomalie suspecte, épaisseur ___mm, longueur à jeun ___cm. Absence de lithiase, absence de liquide péri-vésiculaire, absence de dilatation des voies biliaires.

Pancréas : analyse limitée (interpositions aérodigestives), absence de lésion focale suspecte, absence de dilatation des voies pancréatiques, absence de lithiase.

Rate : mesure ___cm par ___cm. Absence de lésion focale suspecte. Absence de liquide libre péri-splénique

Rein (D / G) : mesure ___cm de grand axe. Morphologie et échogénicité normale. Absence de lésion focale suspecte. Vascularisation rénale globale préservée au Doppler couleur. Absence de dilatation pyélocalicielle ou urétérale.

Reins : mesurent ___cm (D) et ___cm (G) de grand axe. Morphologie et échogénicité normale, symétrique. Absence de lésion focale suspecte. Vascularisation rénale globale préservée au Doppler couleur.

Absence de dilatation pyélocalicielle ou urétérale.

Vessie : absence de lésion focale suspecte. Volume urinaire mesuré ___ml.

Conclusions :

Absence d'anomalie significative décelée, sous réserve des interpositions aérodigestives.

Examen échographique montrant ___ compatible avec ___.

Signature

Superviseur

SERVICE - HÔPITAL

Nom, Prénom, ddn

Echocardiographie POCUS

Indication :

Technique : Ultrason cardiaque trans-thoracique, Machine, Sonde

Qualité d'examen :

Situation clinique:

Rythme et fréquence cardiaque : sinusal, __bpm

Tension art. __/__(__)mmHg

Position du patient :

Mode ventilatoire : ____, PEEP __cmH2O

Médic. vasoactifs :

Résultats :

VG : FEVG normale (>55%) / lég. diminuée (45-55%) / mod. diminuée (30-45%) / sév. diminuée (<30%)

Diam. télédiastolique : __mm

EPSS : __mm

MAPSE : __mm

Diamètre. LVOT : __mm

ITV sous-aortique : __cm

Débit cardiaque : __L/min

VD : Rapport VD/VG normal (<0.6) / dilatation mod. (0.6-1.0) / dilatation sévère (>1.0)

TAPSE : __mm FEVD normale (>20mm) / lég. diminuée (15-20mm) / mod. diminuée (10-15mm) / sév. diminuée (<10mm)

VCI : calibre max : __mm

calibre min : __mm

collapsabilité : __%

POD estimée : __mmHg

Calibre max	Index de collapsibilité %	POD estimée mmHg
≤ 20	≥ 50	5 ou <
	< 50	10
> 20	≥ 50	15
	< 50	20 ou >

Péricarde :

Autre :

Conclusions :

Examen échographique montrant __ compatible avec __.

Signature

Superviseur

SERVICE - HÔPITAL

Nom, Prénom, ddn

Echographie POCUS pleuropulmonaire

Indication :

Technique : Ultrason pleuropulmonaire, Machine, Sonde

Qualité d'examen :

Résultats :

Mode ventilatoire : spontané

	Côté Droit	Côté Gauche
Ligne pleurale		
Pouls pulmonaire		
Lignes A et B		
Consolidations		
Epanchement pleural	Vol. estimé : __ml Drainage : oui / non	Vol. estimé : __ml Drainage : oui / non

Remarques :

Conclusions :

Examen échographique montrant ____ compatible avec ____.

Signature

Superviseur

SERVICE - HÔPITAL

Nom, Prénom, ddn

Echographie POCUS eFAST

Indication : déchocage

Technique : Ultrason en situation d'urgence, Machine, Sonde

Qualité d'examen :

Résultats :

Péricarde (vue sous-xyphoïdienne) : absence de liquide libre péricardique

Espace péri-hépatique :

Absence de liquide libre pleural droit notamment dans le récessus costo-diaphragmatique postérieur

Absence de liquide libre péritonéal dans l'espace hépato-rénal

Espace péri-splénique :

Absence de liquide libre pleural gauche notamment dans le récessus costo-diaphragmatique postérieur

Absence de liquide libre péritonéal dans l'espace spléno-rénal

Gouttières pariéto-coliques :

Absence de liquide libre péritonéal

Pelvis :

Absence de liquide libre péritonéal notamment dans le cul-de-sac recto-vésical / recto-vaginal

Ligne pleurale :

Sur toutes les plages ; glissement pleural visualisé, seashore sign avec le mode M.

Présence d'un pouls pulmonaire. Point poumon non-visualisé.

Conclusions :

Absence d'épanchement péricardique

Absence d'épanchement pleural

Absence d'épanchement péritonéal

Absence de pneumothorax